
Psicologia, Migração e Psicologia Intercultural

Relatório de pesquisa sobre a produção científica do campo

Panorama acadêmico global · Revisão ampla e equilibrada

Setembro de 2026

Sumário

Sumário executivo	3
1. O objeto: a migração como fenômeno psicológico global	4
2. A constituição histórica do campo	6
3. Os grandes modelos teóricos	8
4. A psicologia da migração em evidência: saúde mental	12
5. Relações interculturais e o projeto MIRIPS	15
6. Jovens, famílias e segunda geração	16
7. Clínica, intervenção e políticas	17
8. Os campos da interface cultura-clínica	19
9. Métodos, medidas e a crise de validade do campo	25
10. Viés WEIRD, decolonialidade e novas fronteiras	26
11. A produção em língua portuguesa	28
12. Síntese, lacunas e agenda futura	29

Sumário executivo

A psicologia da migração e a psicologia intercultural formam, hoje, um dos campos mais produtivos e socialmente relevantes da psicologia aplicada. Sustentado por um contexto objetivo — **304 milhões de migrantes internacionais em 2024** (3,7% da população mundial) e **123,2 milhões de pessoas deslocadas forçadamente** (ONU, OMS) —, o campo consolidou-se institucionalmente entre 1970 e 1972, com a fundação do *Journal of Cross-Cultural Psychology* e da International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) (IACCP).

Do ponto de vista teórico, a produção gira em torno de três grandes arquiteturas: o **modelo bidimensional de aculturação de John Berry** (integração, assimilação, separação e marginalização), cujo artigo de 1997 ultrapassa 20.500 citações; o **modelo ABC de Colleen Ward**, que distingue adaptação afetiva, comportamental e cognitiva no choque cultural; e os **modelos de dimensões culturais** de Hofstede, Triandis e Schwartz. Em torno deles, desenvolveram-se linhas robustas de pesquisa empírica: a epidemiologia da saúde mental de refugiados (prevalência de TEPT de **31,5%** e de depressão de **31,5%**, contra 3,9% e 12% na população geral (Blackmore et al., 2020)); os efeitos da discriminação percebida sobre a saúde (correlação meta-analítica de $r \approx -0,20$ (Pascoe & Smart Richman, 2009)); o "paradoxo do imigrante"; os grandes estudos comparativos internacionais (ICSEY, com mais de 7.000 jovens em 13 países; MIRIPS, em 21 sociedades); e as intervenções psicológicas escaláveis da OMS (PM+, Step-by-Step), validadas por ensaios clínicos randomizados.

O campo também atravessa uma fase de autocritica vigorosa: questionamentos psicométricos ao modelo quádruplo de Berry (Rudmin catalogou **126 taxonomias concorrentes de aculturação entre 1918 e 2003** (Rudmin, 2009)), o reconhecimento do viés WEIRD (amostras ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e democráticas), a incorporação de perspectivas decoloniais e interseccionais, e a expansão da produção fora do eixo anglófono — incluindo uma literatura brasileira tardia (primeiro artigo indexado em 2004) mas crescente, centrada sobretudo nas migrações haitiana, venezuelana e africana (SciELO Preprints). Além da psicologia intercultural em sentido estrito, este relatório cobre ainda os **campos irmãos que atuam na interface cultura-clínica** — a etnopsicologia, a etnopsiquiatria, a etnopsicanálise e a psicologia e psiquiatria transculturais —, de Georges Devereux a Tobie Nathan e Marie Rose Moro, incluindo a controvérsia francesa sobre o culturalismo (seção 8). No total, o relatório mapeia toda essa produção em detalhe: fundamentos históricos, modelos teóricos, evidências empíricas, métodos e instrumentos, aplicações clínicas, críticas e agendas futuras.

1. O objeto: a migração como fenômeno psicológico global

1.1 Dimensão demográfica do fenômeno

Nunca houve tantas pessoas vivendo fora do país onde nasceram. Segundo a Divisão de População do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (UNDESA), o estoque global de migrantes internacionais atingiu **304 milhões de pessoas em 2024**, quase o dobro dos 154 milhões estimados em 1990, o que corresponde a 3,7% da população mundial (ONU). As mulheres representam 48% desse contingente, e a Europa e a América do Norte concentram, juntas, 51,1% de todos os migrantes internacionais (155,3 milhões), seguidas pelo Norte da África e Ásia Ocidental (17,8%) (Migration Policy Institute). O Relatório Mundial sobre Migração da OIM estimou 281 milhões de migrantes em 2020 e destacou que as remessas enviadas aos países de origem saltaram de US\$ 128 bilhões para US\$ 831 bilhões entre 2000 e 2022, superando o investimento estrangeiro direto como fonte de recursos para países em desenvolvimento (OIM).

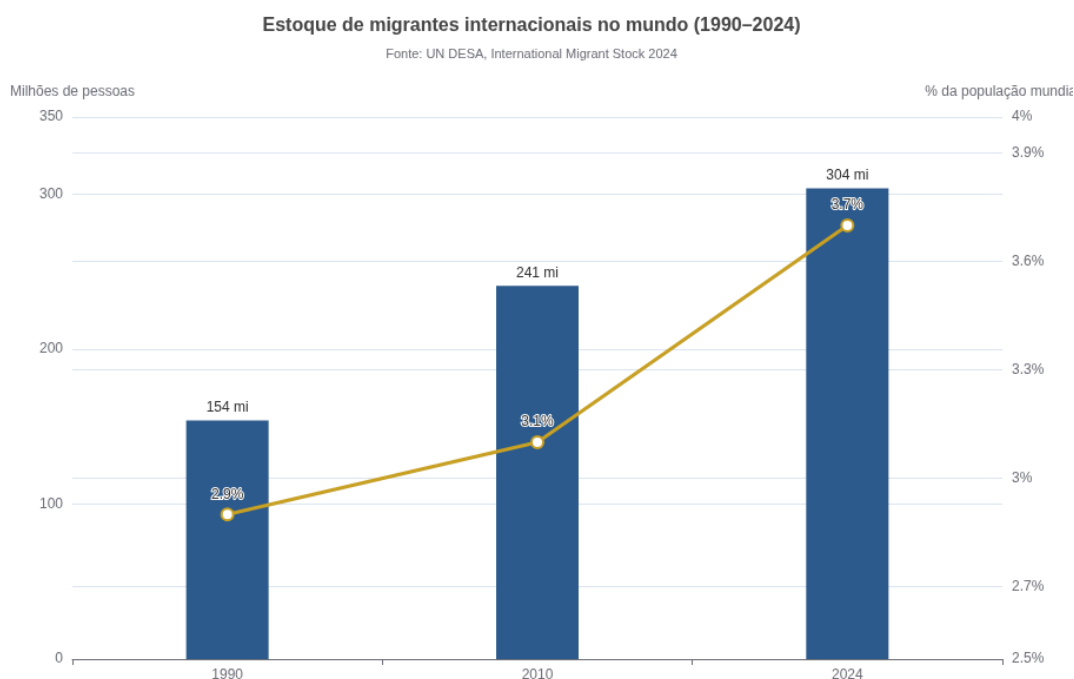


Figura 1 — Estoque de migrantes internacionais no mundo (milhões de pessoas). Fonte: UNDESA/OIM.

Paralelamente à migração voluntária, o deslocamento forçado atingiu níveis sem precedentes: em 2024, **123,2 milhões de pessoas** estavam deslocadas à força em todo o mundo — 73,5 milhões de deslocados internos, 36,8 milhões de refugiados, 8,4 milhões de solicitantes de asilo e 5,9 milhões de outras pessoas necessitando de proteção internacional —, sendo que **71% dos refugiados são acolhidos por países de baixa e média renda (OMS)**. É essa combinação de escala, permanência e diversidade de motivações (trabalho, estudo, reunião familiar, fuga de conflitos e desastres climáticos) que transformou a migração em objeto central da psicologia contemporânea, e não mais em um tema periférico.

1.2 Por que a migração é um problema psicológico

A migração envolve, por definição, o contato sustentado entre culturas e a necessidade de reconstrução de práticas, vínculos, identidade e sentido de pertencimento. A psicologia contribui para o campo migratório em dois domínios principais, já delineados por Berry em seu clássico "A psychology of immigration" (2001): a **aculturação** (as mudanças psicológicas e culturais decorrentes do contato intercultural) e a **adaptação** (os resultados de bem-estar psicológico e competência sociocultural alcançados ao longo do tempo) (Berry, 2001). Uma contribuição mais recente da psicologia do desenvolvimento mostrou, adicionalmente, que migrantes enfrentam simultaneamente tarefas normativas do ciclo vital (como a formação identitária na adolescência) e desafios aculturativos, o que exige desenredar processos de desenvolvimento e de aculturação nas pesquisas sobre saúde mental (PMC).

É importante registrar que a migração não é um "evento" único, mas um processo com fases — pré-migração, trânsito e pós-migração —, cada uma com estressores próprios. O Grupo de Trabalho da Associação Mundial de Psiquiatria (WPA) sobre saúde mental de migrantes e refugiados sintetiza que condições pré-migratórias (privação, perseguição, violência, tortura) e a fase de viagem se associam a depressão, TEPT e ansiedade, mas que **os fatores pós-migratórios podem ter impacto ainda maior sobre a saúde mental**, incluindo separação familiar, barreiras linguísticas, exclusão social, desemprego, estigma e discriminação (WPA, PMC).

2. A constituição histórica do campo

2.1 Raízes e institucionalização (1879–1972)

Embora o interesse pela relação entre cultura e psique remonte à *Völkerpsychologie* de Wilhelm Wundt, a psicologia intercultural e transcultural como empreendimento organizado é um fenômeno da segunda metade do século XX. A cronologia institucional é bem documentada: em 1966, a União Internacional de Ciência Psicológica (IUPsyS), com apoio da UNESCO, fundou o *International Journal of Psychology*; em 1967, Harry Triandis criou o *Cross-Cultural Social Psychology Newsletter* e John Berry concluiu sua dissertação sobre habilidades perceptuais de Inuit e Temne; em 1969, foi criado o Center for Cross-Cultural Research na Western Washington State College; e, em março de **1970, apareceu o primeiro número do *Journal of Cross-Cultural Psychology* (JCCP)**, sob editoria fundadora de Walter Lonner — a primeira revista de psicologia do mundo dedicada exclusivamente à pesquisa transcultural (IACCP, ERIC).

O ano de 1972 completou a arquitetura institucional: a Sage Publications assumiu a publicação do JCCP e foi fundada a **International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP)**, cuja conferência inaugural ocorreu na Universidade de Hong Kong, reunindo cerca de 800 psicólogos de aproximadamente 70 países em torno da missão de estender os horizontes da psicologia para além da esfera euro-americana que dominava a disciplina (Psi Chi, IACCP). A aliança JCCP–IACCP permanece até hoje e foi complementada por periódicos como o *International Journal of Intercultural Relations* (IJIR), o *Journal of Cross-Cultural Psychology*, a *Transcultural Psychiatry* e, mais tarde, o *Journal of International Migration and Integration*.

Tabela 1 — Marcos históricos da psicologia intercultural e da migração

Marco	Ano	Significado
<i>Völkerpsychologie</i> (Wundt)	1900–1920	Antecedente filosófico da psicologia dos povos
Definição antropológica de aculturação (Redfield, Linton & Herskovits)	1936	Primeira formulação sistemática do conceito
Teoria clássica da assimilação (Milton Gordon)	1964	Modelo unilinear de absorção pela cultura majoritária
Dissertação de Berry (Inuit/Temne); <i>Newsletter</i> de Triandis	1967	Início do "movimento moderno"
Center for Cross-Cultural Research (Bellingham)	1969	Primeira infraestrutura dedicada
<i>Journal of Cross-Cultural Psychology</i>	1970	Primeira revista exclusiva da área
Fundação da IACCP (Hong Kong)	1972	Institucionalização internacional
<i>Culture's Consequences</i> (Hofstede)	1980	Paradigma das dimensões culturais nacionais
Modelo quádruplo de aculturação consolidado (Berry)	1989	Estrutura teórica dominante da psicologia da migração

Estudos ICSEY	1997–2006	Maior projeto comparativo com jovens imigrantes
Projeto MIRIPS	2009–2022	Teste pancultural das hipóteses das relações interculturais

2.2 Do paradigma da assimilação ao paradigma bidimensional

O ponto de virada teórico foi o abandono do modelo unilinear. Durante décadas, pressupôs-se que o desfecho inevitável e "saudável" do contato intercultural era a absorção do grupo minoritário pela maioria — formalizada por Milton Gordon (1964) como teoria clássica da assimilação, com estágios sucessivos (cultural, estrutural, marital, cívico) culminando na perda da identidade étnica distinta ([Simply Psychology](#)). Nos anos 1970 e 1980, John Berry contestou esse pressuposto: tornar-se semelhante à cultura de acolhimento não era inevitável nem o único desfecho adaptativo. Sua jogada conceitual decisiva foi tratar a **manutenção da cultura de herança** e a **adoção da cultura de acolhimento** como dimensões independentes — e não como polos de uma única escala —, o que transformou um desfecho binário em uma tipologia de quatro estratégias ([Schwartz et al., 2010](#)).

Essa reformulação, consolidada na representação gráfica de 1989 (Berry, Kim, Power, Young & Bujaki), tornou-se a matriz teórica mais influente da psicologia da migração: o artigo "Immigration, acculturation, and adaptation" (1997), publicado na *Applied Psychology*, acumula mais de **20.500 citações**, e o estudo ICSEY sobre jovens imigrantes (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006) supera 4.400 citações, conforme metadados do Google Scholar. A produção empírica associada é vasta: uma busca pelo termo "acculturation" no PsycINFO já retornava **19.679 entradas** em 2012, das quais 8.469 artigos empíricos revisados por pares ([APA Task Force](#)).

3. Os grandes modelos teóricos

3.1 O modelo bidimensional de aculturação de Berry

O modelo de Berry parte de duas questões formuladas a partir de sua experiência com grupos indígenas australianos e, depois, com a diversidade canadense: "É considerado valioso manter a identidade e as características culturais próprias?" e "É considerado valioso manter relações positivas com os outros grupos da sociedade?" (Ward, 2012). O cruzamento das respostas gera as quatro estratégias clássicas: **integração** (manutenção da herança cultural combinada ao engajamento na sociedade mais ampla, frequentemente equiparada ao biculturalismo), **assimilação** (adoção da cultura de acolhimento com abandono da herança), **separação** (retenção da cultura de origem com evitação do contato externo, frequentemente facilitada por enclaves étnicos) e **marginalização** (distanciamento de ambas as culturas, associado a sentimentos de não pertencimento) (Maricopa Open Textbook).



Figura 2 — As quatro estratégias de aculturação do modelo bidimensional de Berry.

Duas regularidades empíricas emergem de décadas de testes do modelo. A primeira é que **a integração é a estratégia preferida** pela maioria dos indivíduos e grupos em aculturação, em amostras tão diversas quanto coreanos, húngaros, portugueses e gregos no Canadá (Ward, 2012). A segunda é a chamada "**vantagem da integração**": a integração tende a associar-se aos melhores resultados de adaptação psicológica e sociocultural, enquanto a marginalização se associa aos piores — uma revisão sistemática com 61.885 migrantes concluiu que a marginalização **mais do que triplica a probabilidade de sintomas de ansiedade** em comparação com a integração, e que a separação aumenta essa probabilidade em quase seis vezes, estando a integração associada aos menores níveis de sintomas depressivos (Choy et al., 2021). Pesquisas

também mostram que as estratégias variam por domínio de vida: um mesmo indivíduo pode adotar separação na vida privada e integração ou assimilação na esfera pública (Arends-Tóth & van de Vijver, 2004, citado em [Maricopa](#)).

O modelo também gerou um programa de pesquisa sobre o **estresse aculturativo** (*acculturative stress*), conceito preferido por Berry ao antigo "choque cultural" por situar o sofrimento na interação entre o migrante e as instituições da sociedade de acolhimento ([Berry, 2006](#)). Uma meta-análise sobre a literatura norte-americana confirmou que maior estresse aculturativo se relaciona significativamente com piores indicadores de saúde mental, com efeitos amplificados em amostras de primeira geração ([eScholarship UC](#)). Um estudo com imigrantes no Chile estimou que o estresse aculturativo, combinado às emoções negativas associadas à discriminação, explica **41,5% dos sintomas de saúde mental** do grupo ([IJERPH](#)).

3.2 O modelo ABC de Ward: afeto, comportamento e cognição

A segunda grande arquitetura teórica é o modelo ABC de Colleen Ward, Stephen Bochner e Adrian Furnham, apresentado em *The Psychology of Culture Shock* (2001), obra que acumula mais de **5.500 citações**. O modelo decompõe as reações ao contato intercultural em três componentes: **Afeto** (a vertente do estresse e do coping, que culmina na *adaptação psicológica* — bem-estar emocional e satisfação), **Comportamento** (a vertente da aprendizagem cultural, que culmina na *adaptação sociocultural* — competência para desempenhar tarefas cotidianas na nova cultura) e **Cognição** (a vertente da percepção social e da identidade, ligada a estereótipos, atitudes intergrupais e autoidentificação) ([Masgoret & Ward, 2006](#)).

A distinção entre adaptação psicológica e sociocultural — antecipada empiricamente por Ward e Kennedy (1994, artigo com 1.586 citações) — é uma das contribuições conceituais mais duradouras do campo: as duas formas de adaptação são empiricamente relacionadas, mas têm preditores e trajetórias temporais distintos, sendo a adaptação sociocultural mais sensível à proficiência linguística e à quantidade de contato, e a adaptação psicológica mais sensível ao apoio social e aos eventos estressantes ([Ward & Kennedy, 1994](#)). O modelo ABC é hoje o referencial dominante na pesquisa com estudantes internacionais e expatriados ([Zhou et al., 2008](#)).

3.3 As dimensões culturais: Hofstede, Triandis e Schwartz

Em paralelo à psicologia da aculturação, desenvolveu-se a tradição das dimensões de cultura nacional. A partir de 116 mil questionários aplicados a funcionários da IBM em mais de 50 países entre 1967 e 1973, Geert Hofstede identificou quatro dimensões — distância de poder, individualismo versus coletivismo, evitação de incerteza e masculinidade versus feminilidade —, às quais se somaram depois a orientação de longo prazo (com base em instrumento chinês, via Michael Bond) e a indulgência versus contenção (Michael Minkov), totalizando seis dimensões ([Simply Psychology](#), [Maricopa](#)). O individualismo-coletivismo tornou-se a dimensão mais utilizada e de maior poder preditivo, presente em todos os frameworks culturais (Hofstede, Schwartz, GLOBE, Welzel), conforme meta-análise de 598 estudos de Taras, Kirkman e Steel (2010), citada em ([PMC](#)).

O modelo de Hofstede é também um dos mais contestados: críticas apontam a idade e a não representatividade dos dados da IBM, a validade de conteúdo limitada e a confusão entre níveis de análise (país versus indivíduo). Em 2023, os escores de individualismo-coletivismo foram atualizados com base em dados de 2015 da Hofstede Insights e do World Values Survey, cobrindo 102 países, e o constructo foi redefinido em três facetas (conformismo, ascensão social e exclusionismo) ([IJIR, 2025](#)). Shalom Schwartz propôs uma alternativa com sete tipos de valores culturais (conservação, hierarquia, autonomia intelectual, autonomia afetiva, harmonia, igualitarismo e maestria), estruturados em dimensões bipolares, parcialmente convergentes com Hofstede, mas conceitualmente mais refinados — notadamente ao distinguir o coletivismo de grupo (*in-group*) do coletivismo universalista ([Psicothema](#)).

3.4 Identidade étnica, biculturalismo e integração identitária

A terceira família teórica trata da identidade. Jean Phinney desenvolveu o modelo de desenvolvimento da identidade étnica (baseado em Marcia), que se tornou padrão na pesquisa com adolescentes imigrantes; seu artigo de 2001 sobre identidade étnica, imigração e bem-estar, em perspectiva interacional, acumula mais de 3.300 citações ([Phinney et al., 2001](#)). Verónica Benet-Martínez introduziu o constructo de **Integração da Identidade Bicultural (BII)**: o grau em que o indivíduo percebe suas duas identidades culturais como compatíveis ou opostas, com evidências experimentais de *cultural frame switching* — biculturais chineses-americanos expostos a ícones culturais ocidentais faziam atribuições internalistas a comportamentos, enquanto os expostos a ícones asiáticos faziam atribuições externalistas, padrão que se invertia em pessoas com BII baixo ([EMich](#)).

A literatura recente avança para teorias multifacetadas do biculturalismo, como a teoria transformativa (West et al., 2017) e a proposta de "proculturação" de Gamsakhurdia, que reformula a adaptação como processo dialógico e criativo de construção do self, em vez de mero ajuste a duas culturas preexistentes ([Springer](#)). Essas propostas refletem a migração do campo de tipologias estáticas para modelos dinâmicos, negociados e contextuais da identidade.

Tabela 2 — Síntese comparativa dos principais modelos teóricos do campo

Modelo	Autores centrais	Núcleo	Principais evidências	Principais críticas
Modelo bidimensional de aculturação	Berry (1974–2017)	2 dimensões → 4 estratégias	Integração associada a melhor adaptação; estudo ICSEY em 13 países	Rudmin (2003): baixa validade preditiva, proliferação de taxonomias
Modelo ABC do choque cultural	Ward, Bochner & Furnham (2001)	Afeto, comportamento, cognição	Distinção empírica entre adaptação psicológica e sociocultural	Difícil operacionalização conjunta dos três componentes
Dimensões culturais nacionais	Hofstede (1980); Schwartz (1994)	Valores culturais mensuráveis por país	Individualismo-coletivismo como dimensão mais preditiva (meta-análise de 598 estudos)	Dados antigos, falácia ecológica, escores revistos em 2023
Identidade étnica e bicultural	Phinney; Benet-Martínez	Desenvolvimento e integração identitária	BII modera o <i>cultural frame switching</i>	Modelos ainda descritivos, com fraca predição de desfechos
Assimilação segmentada	Portes & Zhou (1993)	Trajetórias divergentes da 2ª geração	Artigo com mais de 10.100 citações	Origem sociológica; menos operacionalizado psicometricamente

4. A psicologia da migração em evidência: saúde mental

4.1 Epidemiologia: o peso do trauma e do pós-migratório

A meta-análise de referência de Blackmore e colaboradores (2020, *PLOS Medicine*), com 5.143 refugiados e solicitantes de asilo adultos diagnosticados por entrevista clínica validada em 15 países, estimou prevalência de **31,46% para TEPT** (IC95% 24,43–38,5), **31,5% para depressão** (IC95% 22,64–40,38), 11% para transtornos de ansiedade e 1,51% para psicose (Blackmore et al., 2020). A comparação com os World Mental Health Surveys torna o contraste explícito: na população geral, a prevalência ao longo da vida é de 3,9% para TEPT e 12% para transtornos depressivos — ou seja, refugiados apresentam cerca de **oito vezes mais TEPT e quase três vezes mais depressão**, enquanto ansiedade (11% vs. 16%) e psicose (1,5% vs. 3%) são comparáveis ou menores que na população geral (Blackmore et al., 2020). Um achado particularmente grave é a persistência: não houve diferença de prevalência entre deslocados há menos ou mais de quatro anos, indicando sofrimento psíquico duradouro no ambiente pós-migratório.

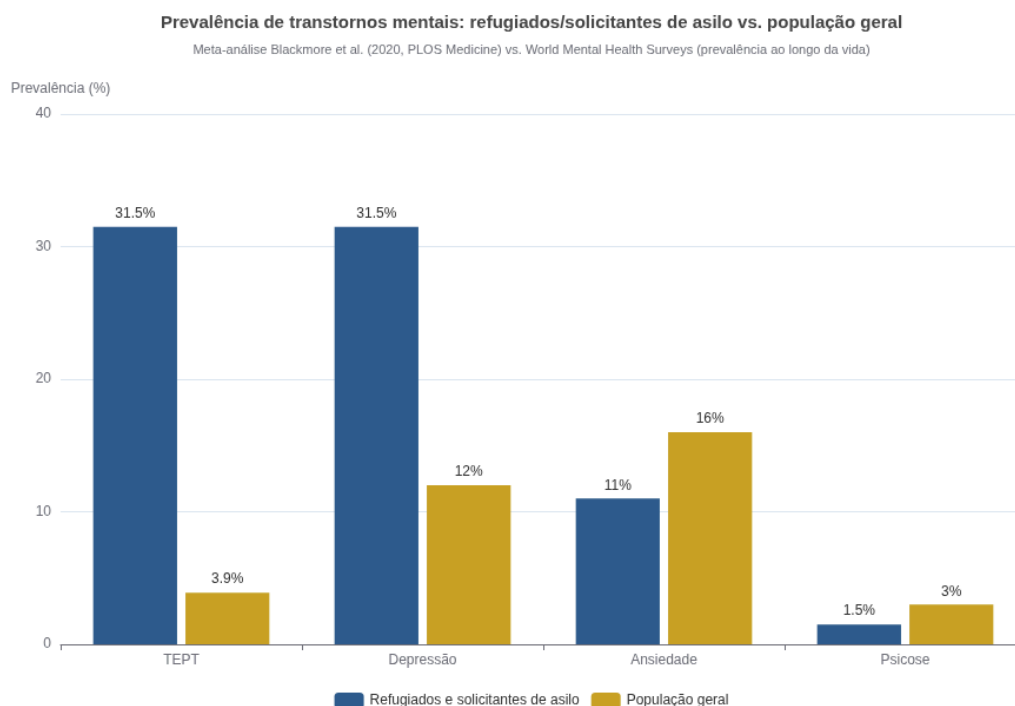


Figura 3 — Prevalência de transtornos mentais em refugiados e solicitantes de asilo versus população geral (%). Fonte: Blackmore et al. (2020).

As estimativas variam por contexto e método. A revisão de Fazel et al. (2005), restrita a grandes amostras em países de alta renda, encontrou 9% de TEPT; a meta-análise de Steel et al. (2009), incluindo populações afetadas por conflito, estimou cerca de 30% para TEPT e depressão; e uma revisão com 8.176 refugiados sírios em 10 países relatou 43% de TEPT, 40% de depressão e 26% de ansiedade (todas citadas em Blackmore et al., 2020). Migrantes em detenção apresentam prevalências ainda mais elevadas de depressão e TEPT do que refugiados não detidos (Verhulsdonk et al., 2021). Há ainda evidência consistente de risco

elevado de psicoses não afetivas entre migrantes: enquanto o risco ao longo da vida na Europa é de 1–2%, pode chegar a **3–6% em migrantes extracuropeus**, associação atribuída a desvantagens sociais cumulativas ao longo da trajetória migratória (WPA, OMS).

A crise ucraniana ofereceu um estudo de caso contemporâneo em tempo real. Um levantamento com 1.165 ucranianos em busca de ajuda psicológica on-line em 24 países da UE, realizado semanas após a invasão de 2022, encontrou **81% abaixo do ponto de corte para depressão** no WHO-5 e 57% com sofrimento psicológico grave, com refugiados e deslocados internos em risco particularmente alto (Asanov et al., 2023). O estudo populacional MAP, com amostragem aleatória de 6.036 ucranianos em 10 regiões e 657 refugiados em Zurique, estimou prevalências ajustadas (via modelagem bayesiana) de depressão entre 19,6% e 54,8%, de ansiedade entre 3,7% e 33,4% e de TEPT entre 15% e 41,2%, com gradiente regional claro (maior carga no centro-sudeste do país) e com a saúde mental dos refugiados assemelhando-se à das regiões mais atingidas pela guerra (Yasenok et al., 2025).

4.2 O paradoxo do imigrante e sua geografia

Uma das descobertas mais discutidas do campo é o **paradoxo do imigrante** (ou paradoxo hispânico): apesar da desvantagem socioeconômica, imigrantes de primeira geração nos Estados Unidos frequentemente apresentam *melhores* indicadores de saúde mental e comportamental do que seus descendentes nascidos no país. A observação originou-se no Epidemiologic Catchment Area Study de Los Angeles e foi confirmada por William Vega e colaboradores: a prevalência de qualquer transtorno psiquiátrico entre mexicano-americanos nascidos nos EUA era o **dobro** da observada entre imigrantes recém-chegados, e a dependência de drogas entre imigrantes era inferior a um quarto da dos nascidos no país (ASA Footnotes). Entre jovens, a segunda geração latina apresenta quase três vezes mais tentativas de suicídio e mais que o dobro de uso repetido de maconha em comparação com a primeira geração (Kids Mental Health Foundation).

As explicações candidatas incluem efeitos de seleção (o "imigrante saudável"), redes familiares coesas e valores protetores (como o *familismo* latino), e a erosão desses fatores com a aculturação — exposição a dietas processadas, enfraquecimento de laços familiares, conflito intergeracional e contato crescente com a discriminação (ASA Footnotes, Wikipedia). Contudo, o paradoxo **não é universal**: os dados europeus do SHARE não mostram vantagem dos imigrantes — pelo contrário, imigrantes na Europa apresentam piores resultados de saúde que os nativos — e uma revisão sistemática dos paradoxos imigrante e hispânico encontrou evidências contraditórias e problemas metodológicos relevantes, como o viés do salmão (retorno dos doentes ao país de origem) (Teruya & Bazargan-Hejazi, 2013). No ICSEY, a comparação europeia mostrou jovens imigrantes menos adaptados que seus pares nativos em vários países, um "paradoxo da adaptação" invertido em relação aos EUA (Sam et al., 2008).

4.3 Discriminação: o estressor central

Se há um fator transversalmente associado a resultados adversos, é a discriminação percebida. A meta-análise de Pascoe e Smart Richman (2009, *Psychological Bulletin*), com 134 amostras, demonstrou que a

discriminação percebida tem **efeito negativo significativo sobre a saúde mental e física**, produz respostas de estresse fisiológico amplificadas e se associa a comportamentos prejudiciais à saúde — artigo que acumula mais de **7.100 citações** (Pascoe & Smart Richman, 2009). Meta-análises subsequentes estimaram a correlação com saúde mental em torno de $r = -0,20$ a $-0,23$ e, crucialmente, uma meta-análise de evidência *experimental* de 2024 confirmou efeito causal imediato da discriminação sobre a saúde mental, mais forte quando a discriminação é percebida como perversiva (Emmer et al., 2024).

No quadro teórico de Berry, a discriminação opera como elo entre os níveis individual e societal: indivíduos que optam por integração e assimilação relatam menos discriminação, enquanto separação e marginalização se associam a mais discriminação — e a rejeição percebida tende a ser reciprocada com estratégias de afastamento, em uma dinâmica circular de deterioração das relações intergrupais (Berry, 2013). A teoria do estresse de minoria (Meyer, 2003) e perspectivas interseccionais ampliaram esse enfoque para populações com múltiplas identidades estigmatizadas, como imigrantes hispânicos de minorias sexuais, nos quais discriminação em serviços de saúde e trauma migratório se combinam para produzir desfechos adversos (CUNY).

5. Relações interculturais e o projeto MIRIPS

5.1 As três hipóteses fundamentais

A psicologia intercultural não estuda apenas o migrante: estuda a *relação* entre grupos. A partir da política canadense de multiculturalismo (1971), Berry e colaboradores extraíram três hipóteses psicológicas testáveis: a **hipótese do multiculturalismo** (segurança na própria identidade cultural é condição psicológica para a aceitação do outro; ameaça identitária gera hostilidade), a **hipótese do contato** (maior contato intergrupar leva a maior aceitação mútua, sob condições de igualdade de status, voluntariedade e apoio institucional — formulação que remonta a Allport, 1954) e a **hipótese da integração** (o "duplo engajamento" na cultura de herança e na sociedade mais ampla produz melhor adaptação psicológica, sociocultural e intercultural) ([ScholarWorks GVSU](#)).

O projeto **MIRIPS (Mutual Intercultural Relations in Plural Societies)** testou essas hipóteses em 17 a 21 sociedades culturalmente plurais — incluindo Austrália, Canadá, Alemanha, Índia, Itália, Noruega, Portugal, Rússia e Suíça —, com 7.485 participantes de grupos dominantes e 5.888 de grupos não dominantes. A meta-análise interna encontrou apoio à hipótese do multiculturalismo em **36 de 39 avaliações possíveis (92%)**, à hipótese do contato em 28 de 35 (80%) e à hipótese da integração em 29 de 37 (78%), com concordância entre amostras dominantes e não dominantes em 69% das avaliações por sociedade ([Berry et al., 2022, GVSU](#)). A meta-análise de Pettigrew e Tropp (2011), cobrindo centenas de estudos sobre contato intergrupar, já havia demonstrado que maior contato se associa tipicamente a menor preconceito, com efeito mais forte onde programas estruturados incorporam as condições de Allport ([Redalyc](#)).

5.2 Políticas nacionais fazem diferença

Evidências comparativas mostram que o contexto nacional modula os processos psicológicos. Na comparação entre jovens imigrantes de segunda geração no Canadá e na França, o contexto francês apresentava mais discriminação, menor orientação à cultura de herança e pior adaptação (menor autoestima, maior desvio de conduta), e a relação entre integração e boa adaptação — presente nos dois países — era menos intensa na França, o que os autores interpretaram como reflexo do maior custo psicológico de expressar a etnia em um contexto republicano-assimilacionista ([Berry & Sabatier, via Redalyc](#)). Esse tipo de achado sustenta o argumento central da psicologia intercultural aplicada: **as estratégias individuais de aculturação não são escolhas puramente pessoais, mas respostas a contextos de políticas, normas e atitudes** da sociedade de acolhimento.

6. Jovens, famílias e segunda geração

6.1 O estudo ICSEY e a adaptação de jovens imigrantes

O **International Comparative Study of Ethnocultural Youth (ICSEY)** é o maior projeto empírico da psicologia da migração juvenil: coordenado por Berry, Phinney, Sam e Vedder, coletou dados de mais de **7.000 jovens imigrantes em 13 países**, articulando aculturação, identidade e adaptação (Berry et al., 2006, [livro ICSEY](#)). Seus principais achados: os jovens imigrantes preferem majoritariamente perfis de integração; o perfil integrado se associa à melhor adaptação psicológica e sociocultural; e a discriminação percebida é o preditor mais consistente de maus resultados. A identidade bicultural — forte identificação simultânea com o grupo étnico e com a sociedade nacional — emergiu como recurso adaptativo central.

A pesquisa sobre famílias imigrantes documenta ainda o fenômeno das **diferenças intra-familiares de aculturação** (*acculturation gaps*): filhos aculturam-se mais rápido que os pais, o que pode gerar conflitos intergeracionais associados a piores resultados para os jovens, embora a literatura sobre a direção causal desse efeito seja mista ([Frontiers](#)). A perspectiva do desenvolvimento acrescentou que tarefas normativas da adolescência interagem com os desafios aculturativos — por exemplo, o efeito protetor da idade contra vitimização, observado entre não migrantes, só emerge entre jovens imigrantes após três a quatro anos no novo país, segundo estudos em Israel e Alemanha ([PMC](#)).

6.2 Assimilação segmentada e trajetórias divergentes

Da sociologia, a teoria da **assimilação segmentada** de Portes e Zhou (1993) — com mais de **10.100 citações** — influenciou profundamente a psicologia ao propor que a segunda geração não segue um caminho único de integração: dependendo do capital humano dos pais, da estrutura de oportunidades e do contexto de recepção, os descendentes de imigrantes podem integrar-se à classe média majoritária, permanecer em enclaves étnicos economicamente viáveis ou assimilar-se "para baixo", aproximando-se de populações urbanas marginalizadas ([Portes & Zhou, 1993](#)). Extensões psicológicas incluem o modelo de aculturação tridimensional de Ferguson e Bornstein para imigrantes caribenhos negros nos EUA, que incorpora a cultura afro-americana local como terceiro referencial, e o conceito de *remote acculturation* (aculturação à distância, por exposição a culturas de países para os quais não se migrou) ([Ferguson & Bornstein, 2013](#)).

No domínio educacional, a pesquisa com jovens imigrantes na Suíça mostrou que o histórico migratório, a aculturação e o contexto escolar contribuem separadamente para a adaptação e o sucesso escolar ([Haenni Hoti et al., 2017](#)). Obrigações familiares explicam parte do paradoxo do imigrante no ajuste escolar: o forte sentido de dever familiar funciona como recurso motivacional protetor entre jovens de primeira geração ([Van Geel & Vedder, 2011](#)).

7. Clínica, intervenção e políticas

7.1 Psicologia transcultural e competência cultural

A interface clínica do campo é ocupada pela psicologia e psiquiatria transculturais. Laurence Kirmayer e colaboradores (Universidade McGill) lideraram a reflexão crítica sobre a **competência cultural**: em vez de um conjunto fixo de conhecimentos sobre "culturas", Kirmayer propõe uma postura clínica baseada em formulação cultural caso a caso, atenção a estruturas de poder e reconhecimento de que a maioria das intervenções psicológicas é fundada em pressupostos individualistas — o que torna a adaptação cultural não um acessório, mas uma condição de efetividade (Kirmayer, 2012a, Kirmayer, 2012b). O DSM-5 incorporou essa agenda com a **Entrevista de Formulação Cultural (CFI)**, instrumento semiestruturado para eliciar explicações culturais do sofrimento, identidades e estressores psicossociais. A literatura sobre adaptação cultural de intervenções baseadas em evidências indica benefícios clínicos moderados a significativos quando as intervenções são efetivamente adaptadas, e não apenas traduzidas (Fennig, 2021).

7.2 Tratamentos com evidência: NET e intervenções focadas em trauma

Para o TEPT em refugiados, a **Terapia de Exposição Narrativa (NET)**, desenvolvida por Schauer, Neuner e Elbert, é a intervenção com evidência mais específica para populações com múltiplos traumas. A meta-análise de Lely et al. (2019) mostrou que a NET é eficaz na redução de sintomas de TEPT e depressão em populações predominantemente de refugiados afetados por guerra, superior a comparadores inativos e a intervenções ativas não focadas em trauma, com a vantagem de funcionar com terapeutas paraprofissionais e doses baixas de tratamento — características que aumentam sua validade externa em contextos de baixos recursos (Lely et al., 2019). Um estudo de viabilidade com refugiados sírios na Jordânia encontrou tamanhos de efeito moderados para trauma ($d = 0,73$) e depressão ($d = 0,79$) e grande para ansiedade ($d = 0,97$), com 100% de retenção (ScienceDirect, 2023). Meta-análises mais amplas de intervenções psicológicas para refugiados confirmam que tratamentos focados em trauma têm o melhor suporte para TEPT, enquanto efeitos sobre depressão e ansiedade são consistentes, porém mais modestos (Thompson et al., 2018, Kip et al., 2020).

7.3 A revolução das intervenções escaláveis: PM+ e o modelo escalonado

Diante da magnitude do problema — centenas de milhões de pessoas em adversidade e escassez crônica de especialistas —, a OMS desenvolveu, a partir de 2016, um conjunto de **intervenções psicológicas escaláveis**, breves, transdiagnósticas e aplicáveis por não especialistas treinados (*task-sharing*). A principal é o **Problem Management Plus (PM+)**: cinco sessões cobrindo manejo do estresse (respiração diafragmática), resolução de problemas, ativação comportamental e acesso a apoio social. Uma revisão de escopo com 42 estudos (25 deles ECAs) concluiu que o PM+ é viável, aceitável, seguro e eficaz, com tamanhos de efeito moderados a grandes sobre depressão, ansiedade, sofrimento psicológico, TEPT e prejuízo funcional em seguimentos de curto prazo (BJPsych Open, 2024).

O ECA com 206 refugiados sírios na Holanda, com aplicadores que eram eles próprios refugiados sírios treinados, encontrou reduções significativas de depressão/ansiedade ($d = 0,41$), TEPT ($d = 0,39$) e problemas autoidentificados aos 3 meses ([BMJ Mental Health, 2023](#)); no seguimento de 12 meses, mantiveram-se os efeitos sobre sofrimento psicológico ($d = 0,28$) e ansiedade ($d = 0,31$), mas não sobre depressão e TEPT, sugerindo a necessidade de sessões de reforço ou módulos focados em trauma dentro de um modelo de cuidado escalonado (*stepped care*) ([de Graaff et al., 2024](#)). Uma meta-análise de dados individuais de 14 ECAs ($N = 3.203$) com refugiados sírios confirmou efeitos pequenos mas consistentes de PM+ e Step-by-Step, maiores para formatos individuais e para participantes com sintomas clinicamente elevados ([SSRN, 2025](#)). Interessantemente, análises combinadas mostram que o PM+ também reduz **dificuldades de vida pós-migratórias** (estressores interpessoais e familiares), indicando que intervenções psicológicas breves podem atuar sobre os determinantes sociais do sofrimento ([SPIRIT Network](#)).

7.4 O que funciona, em síntese

Tabela 3 — Síntese das evidências sobre intervenções psicológicas para migrantes e refugiados

Abordagem	Evidência central	Efeito típico	Observações
Terapia de Exposição Narrativa (NET)	Meta-análise Lely et al. (2019)	Superior a controles inativos e não focados em trauma	Funciona com paraprofissionais; indicada para trauma múltiplo
Intervenções focadas em trauma (TCC-TF)	Meta-análises Thompson et al. (2018); Turrini et al. (2019/2025)	Melhor suporte para TEPT	Efeitos sobre depressão e ansiedade mais modestos
PM+ (OMS, <i>task-sharing</i>)	25 ECAs; ECA holandês $d = 0,41$	Moderado a grande em curto prazo	Escalável; efeitos de longo prazo parciais
Step-by-Step (digital autoguiado, OMS)	IPD meta-análise de 14 ECAs	Efeitos pequenos, maiores em sintomas elevados	Formato digital amplia alcance
Adaptação cultural de TCC/TIP	Revisões de adaptações culturais	Benefício moderado a significativo vs. não adaptadas	Adaptação > mera tradução
Modelos de cuidado escalonado	Projetos STRENGTHS; piloto na Jordânia	Viabilidade demonstrada	Requer integração institucional e supervisão

8. Os campos da interface cultura–clínica: etnopsicologia, etnopsiquiatria, etnopsicanálise e psicologia transcultural

A psicologia da migração e a psicologia intercultural não esgotam o espaço de saberes que trabalham o encontro entre cultura e psiquismo. Em torno delas — e em diálogo nem sempre pacífico — constituíram-se quatro campos vizinhos, todos com forte interface com a questão migratória: a **etnopsicologia**, a **etnopsiquiatria**, a **etnopsicanálise** e a **psicologia transcultural** (com sua contraparte psiquiátrica). Embora compartilhem o objeto (a relação entre culturas e vida mental), diferem por matriz disciplinar, método e época de consolidação, como resume a Tabela 4.

8.1 Etnopsicologia: a psicologia dos povos

A etnopsicologia é o mais antigo desses campos. O termo foi cunhado por **Moritz Lazarus e Heymann Steinthal** em meados do século XIX, para designar o estudo do "espírito dos povos" (*Völkergeist*), com duas componentes: uma psicologia etno-histórica (o funcionamento geral do espírito de um povo) e uma etnologia psíquica (sua encarnação concreta em línguas, mitologias, religiões e costumes) ([RJHSS](#)). Wilhelm Wundt retomou o programa ao publicar sua *Völkerpsychologie* em dez volumes (1900–1920), concebida como a superestrutura necessária da psicologia experimental: caberia à etnopsicologia estudar os produtos mentais criados pelas comunidades — linguagem, mito e costume —, que a psicologia de laboratório, restrita à vida mental individual, não alcançava ([RJHSS](#)). Em sentido contemporâneo, a etnopsicologia é definida como campo multidisciplinar que estuda as características psicológicas dos grupos étnicos e a influência de costumes, línguas e valores compartilhados sobre processos mentais e comportamentos ([Academia.edu](#), [StudySmarter](#)).

Na América Latina, a etnopsicologia ganhou uma tradição própria com a escola mexicana de **Rogelio Díaz-Guerrero**, para quem a personalidade se estabelece na dialética entre a informação biopsíquica e o componente sociocultural — um programa que gerou instrumentos psicométricos construídos dentro da cultura mexicana (como as escalas de "obediência afiliativa" e de locus de controle interno afetivo de Díaz-Loving, Andrade Palos e La Rosa), em vez de meramente traduzidos de instrumentos anglo-americanos ([Redalyc](#), [UAL](#)). Essa vertente aproxima-se das chamadas **psicologias indígenas**, que buscam construir ciência psicológica a partir dos pressupostos filosóficos de cada tradição cultural, e representa o parente mais próximo, na pesquisa básica, da psicologia intercultural quantitativa tratada nas seções anteriores.

8.2 Etnopsiquiatria e etnopsicanálise: Devereux e o complementarismo

A etnopsiquiatria nasce da articulação entre psiquiatria, psicanálise e etnologia. Seu antecedente direto é a controvérsia entre Bronislaw Malinowski e Freud sobre a universalidade do complexo de Édipo, que levou **Géza Róheim** — enviado ao campo a convite do próprio Freud — a inaugurar a pesquisa psicanalítica em sociedades não ocidentais; coube a **Georges Devereux (1908–1985)** unificar etnopsiquiatria e etnopsicanálise, estabelecendo "as bases de uma espécie de antropologia da loucura, que recorria, ao mesmo

tempo, à psicanálise, à psiquiatria e à etnologia" ([Redalyc](#)). Nascido em Lugo (então Hungria), formado na antropologia francesa de Mauss e doutorado nos EUA sob orientação de Alfred Kroeber, Devereux conduziu na Clínica Menninger a psicoterapia do índio das planícies Jimmy Picard, cujas transcrições deram origem a *Reality and Dream* (1951) — obra adaptada ao cinema em 2013 como *Jimmy P.* — e consolidou o campo nos *Essais d'ethnopsychiatrie générale* (1970) e em *Ethnopsychanalyse complémentaire* (1972) ([Memorandum/UFGM, Domingues et al., 2019](#)). Curiosidade historiográfica: foi o próprio Devereux quem forjou, em 1951, a expressão "psiquiatria transcultural", da qual depois se dissociou ao acusar a psiquiatria norte-americana de usurpá-la no sentido de uma "psiquiatria dos outros", preferindo o termo etnopsiquiatria — tomado de empréstimo ao psiquiatra haitiano Louis Mars ([RHSH](#)).

O núcleo epistemológico de Devereux resume-se em três princípios. O primeiro é a **universalidade psíquica**: o funcionamento psíquico é o que define o ser humano, conferindo "o mesmo estatuto (ético, mas também científico) a todos os seres humanos, às suas produções culturais e psíquicas, às suas maneiras de viver e pensar, mesmo que sejam, às vezes, desconcertantes" ([SBPSP](#)). O segundo é o **complementarismo**: inspirado no princípio da complementariedade de Niels Bohr (por sua vez derivado do princípio da incerteza de Heisenberg), exige que todo fenômeno humano seja analisado por pelo menos um duplo discurso — o psicanalítico (o interior, o psiquismo) e o etnológico (o exterior, a cultura) —, nunca simultâneo e jamais fundido em síntese interdisciplinar: "a verdadeira etnopsicanálise não é 'interdisciplinar', mas pluridisciplinar, posto que efetua uma dupla análise de certos fatos, no campo da antropologia, por uma parte, e no campo da psicanálise, por outra" (Devereux, 1972, citado em [Memorandum/UFGM](#)). O terceiro é o **descentramento** do clínico ou pesquisador, que inclui a análise da contratransferência do próprio investigador como principal via de aproximação à objetividade — a tese de que os dados das ciências humanas são de três tipos (o comportamento do observado, as perturbações causadas pelo observador e o comportamento do próprio observador), sendo o último o menos estudado e o mais decisivo ([Memorandum/UFGM, Acta Scientiarum/UEM](#)). Clinicamente, Devereux distinguiu três tipos de psicoterapia etnopsiquiátrica: **intracultural** (paciente e terapeuta da mesma cultura, com atenção à dimensão cultural), **intercultural** (culturas diferentes, com o terapeuta conhecendo e manejando a cultura específica do paciente) e **transcultural** (o terapeuta leva em conta a Cultura em si, como experiência humana universal) ([Domingues et al., 2019](#)).

8.3 O dispositivo clínico: Nathan, Moro e a clínica transcultural

Coube a **Tobie Nathan**, psicólogo e psicanalista francês nascido no Egito e discípulo de Devereux, transformar a etnopsiquiatria em um dispositivo clínico estável destinado a migrantes. A primeira consulta etnopsiquiátrica data de **1979**, no serviço de psiquiatria infantil de Serge Lebovici no Hospital Avicenne (Bobigny, Seine-Saint-Denis) — hospital público criado em 1935 como hospital franco-muçulmano e que atendia a região norte de Paris, marcada pela pobreza e por comunidades de origem africana e asiática ([Domingues et al., 2019](#)). Nathan fundou depois o **Centre Georges-Devereux**, na Universidade Paris 8 (Saint-Denis), onde consolidou seu dispositivo singular: a consulta é conduzida por um **grupo de cerca de quinze terapeutas** já instalados quando o paciente entra, na presença de mediadores e de objetos ritualmente

significativos para a cultura do paciente, partindo do pressuposto de que existem no mundo incontáveis sistemas terapêuticos eficazes que não são redutíveis ao saber ocidental — e que podem ser, para determinados pacientes, mais eficazes e menos agressivos que a psicoterapia convencional, a qual, argumenta Nathan, pode agravar o choque cultural de recém-chegados ([ABRAPSO](#), [Psiconetwork](#)). Entre suas obras centrais figuram *L'influence qui guérit* (1994), *La nouvelle interprétation des rêves* (2011) e *Psychothérapie démocratique* (2012, com Nathalie Zajde) ([Odile Jacob](#), [Centre Georges-Devereux](#)).

A pedopsiquiatra e psicanalista **Marie Rose Moro** deu ao dispositivo sua versão contemporânea mais influente: as **consultas transculturais** para bebês, crianças, adolescentes e suas famílias, criadas no Hospital Avicenne e transferidas depois para a Maison de Solenn (Hospital Cochin, Paris), onde ela dirige o Departamento de Medicina do Adolescente e Psicopatologia e coordena há décadas a pesquisa em saúde mental infantil em situações humanitárias junto a Médicos Sem Fronteiras ([CV M. R. Moro](#), [SBPSP](#)). A clínica transcultural de Moro é descrita como "um pensamento clínico e uma técnica de atendimento ancorada nos conceitos de complementaridade, universalidade psíquica e descentramento", que utiliza a leitura das teorias culturais como via para compreender e conter os desequilíbrios de crianças e famílias em situação de desenraizamento e migração ([Redalyc](#)). Seu *Manuel de psychiatrie transculturelle* (2006, com Quitterie de la Noé e Yael Mouchenik) tornou-se a referência de formação do campo francófono ([ABRAPSO](#)).

8.4 Psiquiatria transcultural e psicologia transcultural

Em paralelo à tradição franco-psicanalítica, a **psiquiatria transcultural** constituiu-se no eixo anglo-canadense: o termo foi consolidado por **Eric Wittkower**, psiquiatra de formação berlinense que se instalou na Universidade McGill (Montreal) em meados dos anos 1950 e ali organizou a Seção de Estudos Psiquiátricos Transculturais, inicialmente com o antropólogo Jacob Fried e o psiquiatra Henri Ellenberger; em 1965, Wittkower a definiu como a extensão multicultural da psiquiatria cultural, ocupada com os aspectos culturais da etiologia, da frequência e da natureza da doença mental em cada unidade cultural ([Jilek, 2014](#)). A conferência internacional de 1965 e a revista *Transcultural Psychiatry* (fundada em 1956 como *Transcultural Psychiatric Research Review*) deram ao campo sua infraestrutura, hoje frequentemente equiparada à psiquiatria cultural ou *cross-cultural* — ramo da psiquiatria ocupado com o contexto cultural dos transtornos mentais e com o desafio da diversidade étnica nos serviços ([Wikipedia](#)). Desde o início, o campo foi atravessado pela tensão entre universalismo e particularismo: na conferência da Federação Mundial de Saúde Mental de 1959, John Rees afirmou não acreditar em "diferenças fundamentais" entre os quadros ouvidos na África e em outros países, "exceto, naturalmente, nos determinantes culturais de alguns sintomas"; e Ari Kiev, autor do volume seminal *Magic, Faith and Healing* (1964), concluía que as doenças mentais repousam sobre mecanismos estruturais básicos comuns, sobre os quais "as diferentes culturas impõem diferenças de conteúdo" ([History of the Human Sciences](#)).

A **psicologia transcultural** funciona, no uso francófono e lusófono, como denominação guarda-chuva da vertente psicológica e clínica desse conjunto — sendo a clínica transcultural de Moro sua face aplicada mais conhecida. Convém notar uma sutileza terminológica legada por Devereux: em seu sentido original,

"transcultural" não designa o estudo comparativo *entre* culturas (para o qual ele reservava "intercultural"), mas o que está *além* de qualquer cultura particular — a Cultura como fenômeno humano universal; no uso corrente, porém, o termo acabou designando quase exatamente o contrário, isto é, o campo da etnopsiquiatria aplicada a pacientes de outras culturas ([RHSH](#)). É nesse sentido corrente que "psicologia transcultural" e "psicologia intercultural" se tornaram, na prática, parcialmente sobrepostas — com a diferença de ênfase entre a tradição clínica (transcultural) e a tradição de pesquisa comparativa (intercultural/cross-cultural) que estrutura este relatório.

8.5 A controvérsia Fassin–Nathan e os limites do culturalismo

Nenhum desses campos escapou à crítica. A mais contundente foi a do antropólogo e médico **Didier Fassin**, no artigo "L'ethnopsychiatrie et ses réseaux. L'influence qui grandit" (*Genèses*, 1999, com mais de 100 citações) e no ensaio "Les politiques de l'ethnopsychiatrie" (2000), que reconstrói a genealogia colonial do campo: a "etnopsicologia" do psiquiatra John Carothers no Quênia, que interpretou a revolta Mau Mau como psicopatologia determinada pela "personalidade kikuyu" e pelo contato com os europeus — legitimando a repressão colonial como prática terapêutica —, seria a matriz da qual a etnopsiquiatria contemporânea nunca se desvencilhou por completo ([Fassin, 2000](#), [Larivée/U. de Montréal](#)). Contra Nathan, Fassin formula a acusação de **culturalismo**: ao explicar os sofrimentos dos imigrados como decorrentes do encontro entre sistemas de pensamento tradicionais e a modernidade, a etnopsiquiatria operaria uma dupla redução — a reificação da cultura (tratada como entidade herdável e transmissível) e a sobredeterminação pelo cultural —, elidindo as condições sociais, econômicas e políticas concretas (precariedade, racismo, situação administrativa) que determinam boa parte dos problemas que levam os migrantes ao médico ([Fassin, 2000](#)).

Nathan respondeu na mesma revista ("Psychothérapie et politique", *Genèses* 38, 2000), acusando os críticos de buscarem a desqualificação moral de uma prática clínica que incomodava os arranjos universitários, e reivindicando que a etnopsiquiatria tornou a psicoterapia dos migrantes um problema social reconhecido ([ethnopsychiatrie.net](#)). Vale registrar que o próprio Devereux já se irritava com leituras culturalistas e etnicizantes de sua teoria, que considerava desvios de sentido ([Fassin, 1999](#), citado em [Larivée](#)). Lida em conjunto com a seção 7, a controvérsia delimita o espaço da síntese contemporânea: nem o universalismo cego à cultura (que torna os instrumentos e categorias ocidentais invisíveis a si mesmos) nem o culturalismo que enclausura o paciente em sua pertença — posição intermediária que a consulta cultural de Kirmayer e a Entrevista de Formulação Cultural do DSM-5 procuram operacionalizar, tratando a cultura como questão clínica a ser formulada caso a caso, e não como essência explicativa.

8.6 A recepção lusófona desses campos

No Brasil, a recepção é recente e passa sobretudo pela psicanálise e pela antropologia. A revisão de Siqueira, Vieira e Lima (2021), cobrindo seis bases de dados (SciELO, BDTD, PePSIC, LILACS, Periódicos CAPES e Google Acadêmico) entre 2010 e 2019, localizou apenas **seis trabalhos nacionais sobre etnopsicanálise** — articulações teóricas, relatos clínicos e teses —, concluindo que a produção é incipiente e que ainda não se pode falar em uma "etnopsicanálise à brasileira" ([Pensata/UNIFESP](#)). O grupo da Universidade Estadual de

Maringá (Eliane Domingues, Wanessa Wonsoski e colaboradores) constitui o núcleo mais ativo: levantamento bibliográfico identificou **12 teses e dissertações brasileiras** que citam Devereux — sendo *Ensaio de Etnopsiquiatria Geral* a obra mais referenciada — e produziu sínteses de suas contribuições metodológicas (o complementarismo e a contratransferência do pesquisador), além de um projeto de extensão de **clínica intercultural** para atendimento psicológico a imigrantes (Scribd/Wonsoski, *Acta Scientiarum/UEM*). No plano clínico, destaca-se a **Clínica Transcultural da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP)**, que desde 2016 atende gratuitamente famílias de migrantes e refugiados em dispositivo grupal psicanalítico inspirado no modelo de Devereux, Nathan e Moro, articulando as dimensões clínica, antropológica e linguística (SBPSP). Estudos de campo com matriz etnopsicanalítica incluem as pesquisas sobre imigrantes haitianos de Ferraz (2020), sobre o racismo em Maringá, e de Barros (2016), sobre os impactos do terremoto de 2010 no Haiti junto a haitianos em Santa Catarina (*Acta Scientiarum/UEM*).

Em Portugal, a interface aparece principalmente na antropologia da saúde e na psiquiatria transcultural aplicada a refugiados e requerentes de asilo, como no trabalho etnográfico de Rego de Sousa e Santinho (Universidade do Porto/CRIA), que sublinha a necessidade de articulação entre psiquiatria e antropologia para evitar "práticas transculturais estéreis, que fragmentam a realidade trazida por imigrantes, refugiados e requerentes de asilo" (*Traditiones/UPorto*). O padrão lusófono, portanto, espelha o internacional com deslocamento de ênfase: onde a psicologia intercultural quantitativa é dominante no eixo anglófono, os campos da interface cultura-clínica desenvolvem-se, em português, primariamente a partir da psicanálise, da antropologia e dos dispositivos clínicos comunitários — complementaridade que o quadro comparativo a seguir sistematiza.

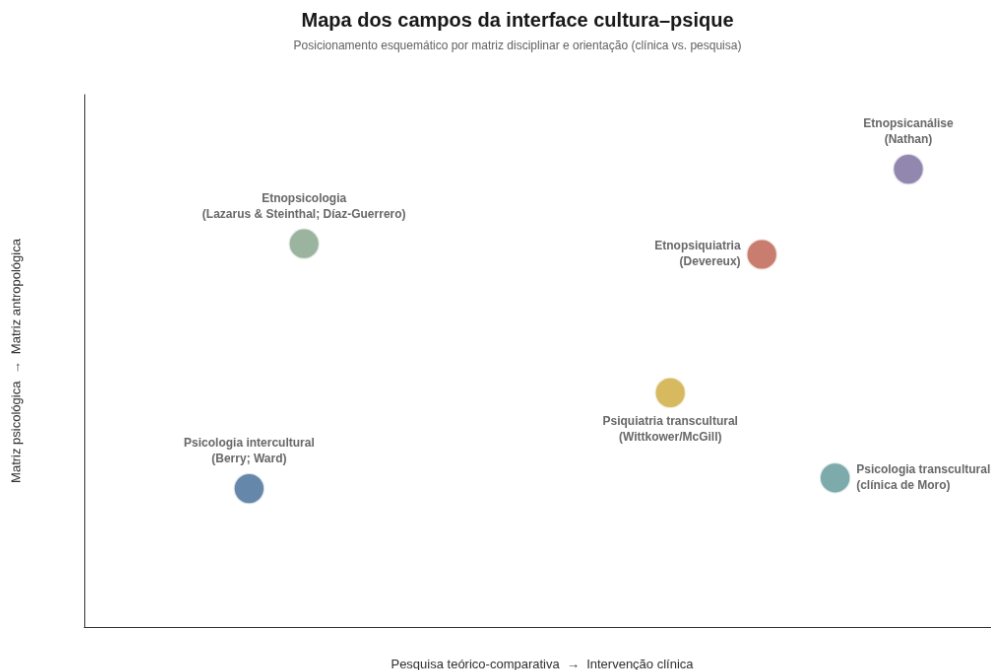


Figura 4 — Posicionamento esquemático dos campos da interface cultura-psyque por matriz disciplinar e orientação (pesquisa comparativa versus intervenção clínica). Elaboração própria.

Tabela 4 — Campos da interface cultura–clínica: síntese comparativa

Campo	Figuras centrais	Objeto	Matriz disciplinar	Interface com a migração
Etnopsicologia	Lazarus & Steintal; Wundt; Díaz-Guerrero	Características psicológicas dos povos e grupos étnicos	Psicologia + antropologia	Psicologia dos povos; identidade étnica; psicologias indígenas
Etnopsiquiatria	Devereux (<i>Essais</i> , 1970)	Relação entre transtornos psíquicos e culturas	Psiquiatria + etnologia + psicanálise	Compreensão do adoecimento psíquico de migrantes
Etnopsicanálise	Devereux; dispositivo clínico de Nathan (1979–)	Psiquismo na particularidade da cultura	Psicanálise + antropologia	Consultas grupais com famílias migrantes (Centre Georges-Devereux)
Psiquiatria transcultural	Wittkower (McGill, 1950s–65); Moro	Aspectos culturais da etiologia e expressão da doença mental	Psiquiatria + antropologia	Serviços de saúde mental e consultas transculturais para imigrantes
Psicologia transcultural	Moro; tradição clínica francófona	Processos psíquicos no encontro entre culturas	Psicologia clínica + psicanálise	Clínica transcultural de crianças e famílias migrantes

9. Métodos, medidas e a crise de validade do campo

9.1 O problema da mensuração da aculturação

A psicometria da aculturação é, reconhecidamente, o elo fraco do campo. A revisão sistemática de Celenk e Van de Vijver (2011) sobre instrumentos de domínio público constatou que a maioria das medidas é **curta, unidimensional e dirigida a grupos-alvo específicos**; que privilegia desfechos comportamentais em detrimento das condições e orientações de aculturação; e que **a validade transcultural dos instrumentos raramente é reportada** — 54,7% dos instrumentos cobrem apenas um dos três componentes do processo (condições, orientações, desfechos) (Celenk & Van de Vijver, 2011). Entre os instrumentos mais utilizados figuram a ARSMA-II (Cuéllar et al., 1995), a escala de Stephenson (SMAS, 2000), o Acculturation Index de Ward e Rana-Deuba (1999) e a Multidimensional Acculturative Stress Inventory (Rodriguez et al., 2002).

O problema é agravado pela heterogeneidade conceitual: Rudmin catalogou **126 taxonomias de aculturação publicadas entre 1918 e 2003**, com terminologia inconsistente e citação fraca dos trabalhos precedentes (Rudmin, 2009). A APA Task Force on Immigration reconheceu explicitamente que "há pouca consistência nos métodos ou na terminologia utilizados nesse grande volume de literatura" (APA). A resposta metodológica contemporânea inclui a exigência de testes de invariância de medida, análises de classes latentes (que recuperaram empiricamente três das quatro categorias de Berry, além de variantes de biculturalismo, em amostras hispânicas de Miami (Schwartz et al., 2010)) e designs longitudinais que substituam os ubíquos estudos transversais.

9.2 A crítica de Rudmin e os limites do modelo de Berry

A crítica mais incisiva ao paradigma dominante veio de Floyd Rudmin. Em sua "história crítica" de 2003 (*Review of General Psychology*, mais de 1.780 citações), ele argumentou que duas dimensões genuinamente contínuas e independentes não deveriam produzir exatamente quatro tipos — tratar integração, assimilação, separação e marginalização como categorias nítidas pode impor estrutura falsa sobre variação contínua — e que o paradigma quádruplo ignorou dezenas de tipologias concorrentes anteriores (Rudmin, 2003, *Simply Psychology*). Estudos psicométricos com migrantes iranianos na Noruega questionaram ainda a confiabilidade das medidas de estratégias (Rudmin & Ahmadzadeh, 2001).

Outras críticas relevantes: a "vantagem da integração" varia conforme a operacionalização da segunda dimensão (contato versus adoção cultural), como demonstraram Ward e Kus com imigrantes na Nova Zelândia; as preferências por estratégias mudam com fatores situacionais (com quem se migra, familiaridade prévia com o idioma), o que compromete a validade preditiva (Zhou, 1997); e a própria categoria de marginalização raramente emerge em análises empíricas (Ward, 2012, *Simply Psychology*). A resposta de Berry e Sam reconheceu as limitações, mas defendeu a utilidade heurística e o amplo suporte empírico transcultural do modelo.

10. Viés WEIRD, decolonialidade e novas fronteiras

10.1 O problema da amostragem ocidental

Uma limitação estrutural do campo é sua base empírica concentrada: a maioria dos estudos de aculturação examina migração de países mais pobres para sociedades WEIRD (ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e democráticas), com muito pouca pesquisa equivalente sobre migração Sul-Sul ou sobre sociedades de acolhimento não ocidentais ([Simply Psychology](#)). Revisões bibliométricas confirmam a concentração da produção nos EUA, Reino Unido, Austrália e Alemanha, com presença marginal de Índia e China ([Frontiers, 2025](#)). Esse desequilíbrio importa teoricamente: achados como a vantagem da integração ou o paradoxo do imigrante podem ser propriedades de contextos de recepção específicos, não universais psicológicos.

10.2 A guinada decolonial e interseccional

A fronteira mais ativa do campo é a incorporação de perspectivas decoloniais e interseccionais. A crítica decolonial questiona o humanitarismo ocidental que constrói o refugiado como "vítima sem voz" e a governança colonial da migração reproduzida por práticas de triagem e atendimento ([Sociology Compass, 2024](#)). Na psicologia comunitária, a psicologia da libertação (tradição de Ignacio Martín-Baró) e epistemologias feministas negras sustentam metodologias participativas que centram a voz e a agência das comunidades migrantes ([PMC, 2025](#)). Propostas recentes articulam psicologia decolonial e feminista interseccional para repensar o reassentamento de refugiados no século XXI, argumentando que inequidades históricas e hierarquias de valor humano continuam a produzir dano e precariedade ([Human Rights Psychology, 2025](#)).

Outras frentes emergentes incluem a migração climática e ambiental como motivador de deslocamento; os efeitos da digitalização sobre identidade e aculturação à distância; o *language brokering* (filhos traduzindo para os pais) como tema de pesquisa familiar; e o uso de análise de dados individuais (IPD) para personalizar intervenções escaláveis. A análise bibliométrica da pesquisa sobre filhos de migrantes identifica a virada para abordagens interseccionais, com termos emergentes como "latinx", "identidades" e "navigating", como a fase mais recente (2015–2025) de um campo que passou por fases de foco educacional (2001–2010) e de consolidação transnacional (2011–2014) ([Springer, 2026](#)).

10.3 O estado da produção: bibliometria do campo

A dimensão da produção científica confirma a maturidade e a expansão acelerada do campo. Uma análise bibliométrica da literatura sobre saúde mental de migrantes internacionais (Web of Science) identificou **6.240 publicações entre 1983 e 2024**: o primeiro artigo data de 1983; a marca de 100 publicações anuais foi superada em 2010; o pico ocorreu em 2021, com 770 artigos; e, nos últimos cinco anos, a produção anual supera consistentemente 500 trabalhos — crescimento que os autores qualificam como "explosivo" ([Farhoudi et al., 2025](#)). A distribuição disciplinar mostra a psiquiatria na liderança (1.863 publicações),

seguida por saúde pública e ocupacional (1.630), psicologia clínica (565), psicologia multidisciplinar (401) e trabalho social (370) — evidência da natureza intrinsecamente multidisciplinar do campo.

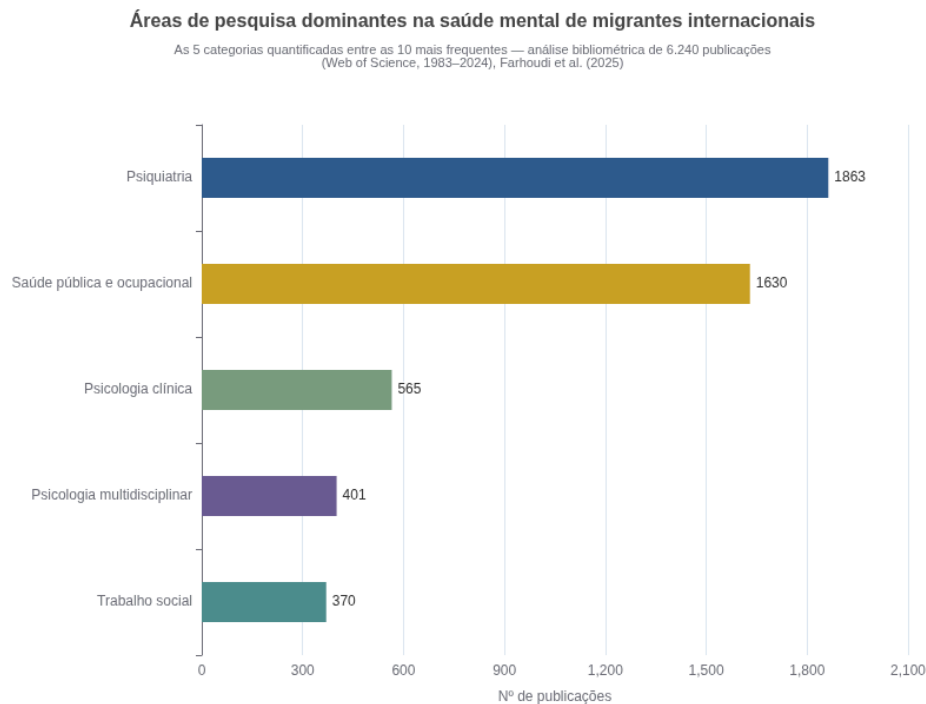


Figura 5 — Áreas de pesquisa dominantes na literatura sobre saúde mental de migrantes internacionais, 1983–2024 (número de publicações). Fonte: Farhoudi et al. (2025).

A estrutura temática dessa literatura organiza-se em clusters de aculturação e estresse psicológico; saúde mental e ajuste de crianças e adolescentes migrantes e refugiados; e resiliência em ambientes de apoio multinível (família, escola, comunidade) (Farhoudi et al., 2025). Uma bibliometria específica sobre pesquisa psicológica com refugiados confirma o mesmo padrão de crescimento acelerado (Emerald).

11. A produção em língua portuguesa

11.1 Brasil: campo tardio, mas em consolidação

A produção brasileira sobre psicologia e migração é recente: a primeira revisão sistemática dedicada a mapear como a psicologia estuda os fluxos migratórios de estrangeiros para o Brasil identificou apenas **17 artigos publicados entre 2004 e 2020**, com concentração em 2017–2019 e foco predominante em migrantes haitianos e africanos ([SciELO Preprints](#)). Os periódicos mais frequentes foram *Psicologia & Sociedade* e a *Brazilian Journal of Psychiatry*; os construtos mais investigados foram saúde mental e psicopatologia (TEPT, ansiedade, depressão), aspectos psicossociais, qualidade de vida e políticas públicas. A revisão aponta lacunas explícitas: ausência de instrumentos validados para o contexto brasileiro, poucos estudos longitudinais e dispersão temática e institucional.

Estudos empíricos representativos incluem a investigação de Brunnet et al. (2017) sobre prevalência de TEPT, ansiedade e depressão em imigrantes haitianos no sul do Brasil (*International Journal of Social Psychiatry*); a pesquisa de Weber et al. (2019) sobre aspectos psicossociais, aculturação, preconceito e qualidade de vida entre haitianos no Rio Grande do Sul (*Psico USF*); o estudo de Bustamante et al. (2020) sobre barreiras ao cuidado e psicopatologia em migrantes bolivianos em São Paulo (*Transcultural Psychiatry*); e a revisão de Bustamante et al. (2018) sobre estresse, trauma e TEPT em migrantes na *Revista Brasileira de Psiquiatria* ([Mackenzie](#)). Existe ainda uma linha psicanalítica vigorosa: uma revisão de 24 artigos publicados no Brasil sobre migração involuntária identificou cinco temas centrais — cultura e diferenças culturais, discurso social, luto, trauma e dispositivos clínicos de acolhimento —, com destaque para a noção de luto migratório e para propostas de clínica transcultural e decolonial ([UFMG](#)).

11.2 Portugal e o espaço lusófono

Portugal ocupa posição singular na produção internacional: é uma das 17 sociedades incluídas no projeto MIRIPS, contribuindo para os testes transculturais das hipóteses do multiculturalismo, do contato e da integração ([GVSU](#)), e pesquisadores portugueses participaram historicamente dos estudos pioneiros de Berry sobre atitudes de aculturação no Canadá (comunidade portuguesa). Félix Neto (Universidade do Porto) é um dos autores mais citados da psicologia intercultural lusófona, com trabalhos sobre adaptação de jovens imigrantes e retornados, integrados à rede ICSEY ([Sam et al., 2008](#)). No espaço lusófono mais amplo, destacam-se os estudos sobre estudantes africanos no Brasil (qualidade de vida, fluxos estudantis) e a revisão sistemática de Danfá e Aléssio (2020) sobre como a psicologia brasileira tem investigado a imigração africana (*Arquivos Brasileiros de Psicologia*) ([Mackenzie](#)).

A leitura conjunta sugere que a produção lusófona reproduz, com duas décadas de atraso, a trajetória do campo internacional: da descrição de casos e da clínica do trauma para estudos quantitativos de aculturação e, mais recentemente, para a reflexão sobre políticas públicas e xenofobia — tema sobre o qual uma revisão de 2007–2017 não encontrou nenhum artigo brasileiro específico ([Pepsic](#)).

12. Síntese, lacunas e agenda futura

12.1 O que o campo estabeleceu

Após cinco décadas de produção, a psicologia da migração e a psicologia intercultural consolidaram um núcleo de conhecimento robusto. Há consenso empírico de que a aculturação é bidimensional (manter a herança cultural e engajar-se na sociedade de acolhimento não são opostos); de que o engajamento duplo — a integração — se associa, na maioria dos contextos estudados, aos melhores resultados de adaptação; de que a discriminação percebida é um estressor com efeitos causais documentados sobre a saúde mental e física; de que refugiados carregam uma carga de TEPT e depressão muito superior à da população geral, que persiste por anos após o reassentamento; e de que intervenções psicológicas — da NET a programas escaláveis como o PM+ — são eficazes, viáveis e implementáveis por não especialistas, inclusive em contextos de baixa renda.

12.2 Lacunas persistentes

As lacunas são igualmente claras. A base empírica permanece concentrada em países WEIRD e em desenhos transversais; a psicometria da aculturação carece de instrumentos com validade transcultural demonstrada; os efeitos de longo prazo das intervenções escaláveis são incertos; populações inteiras — mulheres migrantes, pessoas LGBTQIA+, migrantes idosos, deslocados climáticos — são subestudadas; e a articulação entre fatores estruturais (políticas, racismo institucional) e processos psicológicos individuais ainda é teoricamente frágil. A bibliometria recente aponta a sub-representação das experiências de mulheres descendentes de migrantes e a fraca incorporação dos efeitos da digitalização sobre processos identitários como lacunas teóricas centrais (Springer, 2026).

12.3 Agenda prospectiva

A agenda que emerge da literatura converge em cinco direções: (1) **globalizar a evidência**, financiando pesquisa em corredores Sul-Sul e em sociedades de acolhimento de baixa e média renda — que recebem 71% dos refugiados do mundo (OMS); (2) **longitudinalizar os desenhos**, para separar desenvolvimento, aculturação e seleção; (3) **integrar níveis de análise**, conectando políticas nacionais, contextos comunitários e processos individuais em modelos ecológicos testáveis; (4) **consolidar a prática escalonada e escalável de cuidado**, com módulos focados em trauma, sessões de reforço e integração institucional; e (5) **descolonizar teorias e métodos**, centrando agência, interseccionalidade e produção de conhecimento no Sul global — inclusive fortalecendo a infraestrutura de pesquisa em língua portuguesa, com instrumentos validados, coortes e colaboração Brasil–Portugal–África lusófona.

Em síntese: a psicologia da migração deixou de ser um subcampo exótico para se tornar uma das áreas onde a psicologia mais diretamente responde aos problemas definidores do século XXI. O desafio da próxima

década não é mais demonstrar que cultura importa — é produzir ciência à altura da diversidade real das trajetórias migratórias globais.

Nota metodológica: este relatório foi elaborado a partir de 13 rodadas de busca em bases acadêmicas (Google Scholar via ferramenta dedicada) e fontes institucionais (ONU, OMS, OIM, WPA, APA), priorizando meta-análises, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e relatórios oficiais. Contagens de citações referem-se aos metadados do Google Scholar no momento da pesquisa (setembro de 2026) e são aproximadas por natureza. Este documento tem finalidade exclusivamente informativa e acadêmica e não constitui aconselhamento clínico, psicológico ou profissional.